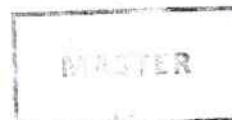


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN SAMPEL DARAH REAKTIF IMLTD

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L2-006
VERSI	:	004
TANGGAL BERLAKU	:	14 FEBRUARI 2015
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 FEBRUARI 2017
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 05 FEBRUARI 2015
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 11 FEBRUARI 2015
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 Februari 2015
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Februari 2015



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN SAMPEL DARAH REAKTIF IMLTD		Halaman 1 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-006 Versi : 004
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan Dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Feb 2027

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses kegiatan dalam melakukan penanganan sampel darah donor dengan hasil pemeriksaan uji saring IMLTD reaktif.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang yang terlibat dalam melakukan penanganan sampel darah donor dengan hasil pemeriksaan uji saring IMLTD reaktif.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Reagensia Uji Saring IMLTD yang digunakan harus disetujui dan direkomendasikan oleh badan yang berwenang untuk uji terhadap:

3.1.1 Hepatitis B *surface* antigen (HBsAg)

3.1.2 HIV 1/HIV 2 *antibody* (anti-HIV1/HIV2)

3.1.3 Hepatitis C *antibody* (anti-HCV)

3.1.4 Sifilis

3.1.5 Jika diinginkan dengan aturan yang berlaku bisa ditambahkan dengan pemeriksaan *Nucleic Acid Amplification Test (NAT)* untuk HBV, HCV dan HIV

3.2 Kriteria Sampel Darah Donor Reaktif:

3.2.1 Hasil uji saring darah donor dengan metode yang digunakan di UDD menunjukkan hasil *Initial Reactive (IR)* pada parameter yang diujikan (HBsAg, anti HIV, anti-HCV dan sifilis)

3.2.2 Pemeriksaan berulang pada metode yang sama sesuai algoritma strategi uji saring IMLTD menunjukkan *Repeated Reactive (RR)*

3.3 Setiap penyumbangan dengan hasil uji saring IMLTD reaktif harus dipisahkan dan dimusnahkan sesegera mungkin

3.4 Setiap sampel yang reaktif harus diperiksa ulang *induplicate* oleh asay yang sama. Jika hasil uji saring ulang *in duplicate* menunjukkan reaktif pada salah satu atau keduanya maka darah dimusnahkan.

3.5 Uji saring ulang *in duplicate* pada sampel yang sama dapat dilakukan dalam kurun waktu penyimpanan sampel yang telah ditetapkan

3.6 Informasi tentang hasil uji saring IMLTD yang reaktif disampaikan melalui konseling

3.7 Butir 7.118

Produk dari donasi reaktif yang telah diperiksa ulang tidak boleh digunakan untuk terapi dan hendaklah dimusnahkan kecuali digunakan untuk tujuan non terapeetik atau investigasi

3.8 Butir 7.135

Algoritma uji saring hendaklah diuraikan secara persis dalam bentuk tertulis (misal SPO) untuk menangani spesimen yang bersifat reaktif dan mengatasi perbedaan hasil setelah dilakukan pengujian ulang. Hendaklah diambil tindakan untuk

DOKUMEN TERKENDALI

MATERI

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN SAMPEL DARAH REAKTIF IMLTD		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-006 Versi : 004
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan Dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Feb 2015 Tanggal kaji ulang : 14 Feb 2021

memastikan bahwa darah dan komponen darah yang reaktif berulang pada saat uji saring untuk penanda penyakit menular dikeluarkan dari penggunaan terapi.

3.9 Butir 7.143

Terhadap hal berikut hendaklah diberikan perhatian khusus”

- 3.9.1 Hasil reaktif awal hendaklah diidentifikasi dengan menggunakan sistem yang aman dan tervalidasi
- 3.9.2 Sistem yang dapat diterima hendaklah tersedia untuk memastikan hasil reaktif ulang, termasuk pengambilan sampel, pelabelan, pengujian dan pengenterian hasil
- 3.9.3 Algoritma komputer hendaklah mengubah status reaktif menjadi reaktif berulang, atau perubahan hendaklah dilakukan oleh dua personil yang berwenang;
- 3.9.4 Sistem penolakan yang sesuai hendaklah tersedia untuk hasil reaktif berulang;
- 3.9.5 Hendaklah tersedia dokumentasi yang sesuai untuk menjustifikasi penerimaan kembali donor yang ditolak;
- 3.9.6 Donor hendaklah diberikan informasi mengenai alasan penolakan dan hendaklah diberikan konsultasi mengenai perilaku sosial dan status mereka sebagai donor di waktu yang akan datang.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No.91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 IMLTD adalah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
- 5.2 *Initial Reactive* (IR) adalah hasil tes pertama kali dari metode yang digunakan untuk uji saring imltd terhadap HBsAg, anti HIV, anti-HCV dan sifilis menunjukkan reaktif
- 5.3 *Repeated Reactive* (RR) adalah hasil tes pengulangan (duplikat) dari metode yang digunakan untuk uji saring imltd terhadap HBsAg, anti HIV, anti-HCV dan sifilis menunjukkan reaktif
- 5.4 Uji Saring IMLTD merupakan salah satu tahap di dalam pengelolaan darah yang dilakukan oleh Palang merah Indonesia (PMI) untuk mendapatkan darah yang aman bagi pengguna darah dengan menyaring beberapa penyakit Infeksi Yang Menular Lewat Transfusi Darah

DOKUMEN TERKENDALI

Salah satu dari





Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENANGANAN SAMPEL DARAH REAKTIF
IMLTD**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub. Bidang
Rujukan Dan Litbang

Halaman 3 dari 4

Nomor : UDDP-IMLTD-L2-006

Versi : 004

Tanggal berlaku : 14 Feb 2015

Tanggal kaji ulang : 14 Feb 2027

6. Peran Dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	• Mengesahkan SPO Penanganan Sampel Darah Reaktif • Melakukan kontrol dokumen • Memberikan nomor register pada formulir dan SPO • Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler berjalan baik
Kepala Bidang Pelayanan Darah	• Membuat kebijakan secara umum pada bidang pelayanan UDDP dan secara khusus terkait dengan penanganan sampel darah reaktif • Memberikan persetujuan pada keseluruhan kegiatan yang berlangsung di bidang pelayanan UDDP khususnya terkait dengan penanganan sampel darah reaktif • Memastikan bahwa sampel darah reaktif ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku • Menyetujui SPO Penanganan Sampel Darah Reaktif
Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Mengawasi proses penanganan sampel darah reaktif IMLTD • Menjelaskan SPO ini kepada seluruh staf di sub bidang Rujukan dan Litbang • Memeriksa pencatatan dan dokumentasi pada penanganan sampel darah reaktif IMLTD setiap minggu dan bulannya secara periodik untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan tercatat. • Memeriksa dan memastikan bahwa setiap penanganan sampel darah reaktif IMLTD sesuai dengan SPO yang telah disetujui. • Menandatangani dengan konfirmasi bahwa telah diperiksa.
Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Melakukan penanganan sampel darah reaktif IMLTD sesuai dengan SPO yang telah disetujui. • Melakukan pencatatan dan dokumentasi setiap formulir yang telah di tanda tangani dengan lengkap dan disahkan oleh penanggung jawab • Menyusun dan mengkaji ulang SPO Penanganan Darah Reaktif

DOKUMEN TERKENDALI

Sub. Litbang

14 Feb 2015

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN SAMPEL DARAH REAKTIF IMLTD		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2-006 Versi : 004
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan Dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Feb 2027

7. Prosedur

- 7.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan penanganan pada sampel darah reaktif IMLTD
- 7.2 Pastikan bahwa sampel darah donor telah diperiksa sesuai dengan Algoritma Strategi Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L5-001) dan menggunakan reagensia yang disetujui dan telah direkomendasikan terhadap parameter HBsAg, anti HCV, anti HIV dan sifilis. Hal ini juga berlaku bila menggunakan pemeriksaan NAT
- 7.3 Pastikan bahwa hasil pemeriksaan telah divalidasi sesuai ketentuan keberterimaan pada *insert kit*
- 7.4 Lakukan pelaporan pada Formulir Hasil Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L4-006)
- 7.5 Simpan sampel darah reaktif selama 1 (satu) minggu sebagai arsip apabila ada keluhan dari pihak luar
- 7.6 Lakukan pemusnahan sampel darah reaktif setelah lebih dari 1 (minggu) dan tidak ada keluhan dari pihak luar
- 7.7 Laporkan hasil sampel darah dengan hasil reaktif ke bagian penyimpanan darah, agar bisa melakukan penarikan produk darah dengan hasil IMLTD reaktif
- 7.8 Simpan produk darah reaktif dalam bentuk plasma sebagai bahan pembuatan panel plasma IMLTD, dan musnahkan kantong darah reaktif (PRC).

8. Dokumen Terkait

- 8.1 SPO Pembuatan Panel Plasma IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-005)

9. Lampiran

- 9.1 Formulir Hasil Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L4-006)
 9.2 Algoritma Strategi Uji Saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L5-001)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru
002	10/01/2023		Perubahan peran Manajer Kualitas terhadap SPO pemusnahan darah reaktif
003	16/07/2024	PMK No.91 Tahun 2015	Perubahan pelaporan dan penyimpanan darah reaktif
004	14/02/2025	CPOB	Perubahan nomor dokumen (Instruksi Kerja, formulir dan ceklis)

DOKUMEN TERKENDALI

Salah satu

MASTER